ATENCIÓN DE LA HEMATURIA EN URGENCIAS

Redactado por:	Aprobado por:
Dr. JM. Alcázar Peral Médico Adjunto Hospitalización Urología Médico Adjunto Urgencias *Fecha julio,* 2022	Dra. C. González-Enguita *Jefa de Servicio –Urología* Dr. A. Blanco y Dr. J. García-Cañete *Jefes de Servicio –Urgencias*

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....3
2. DESARROLLO....3
3. ANEXOS....6
4. BIBLIOGRAFÍA....6

1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de esta guía es el establecer una pauta de actuación conjunta entre el Servicio de Urología y el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) a la hora de atender al paciente que acude por hematuria macroscópica. Con una serie de criterios unificados y de etapas protocolizadas en el manejo de esta entidad, podremos garantizar una atención estandarizada y rigurosa a este paciente

La hematuria macroscópica es uno de los síntomas urológicos más frecuentes. A diferencia de la microhematuria, la macrohematuria o hematuria macroscópica es aquella orina que está teñida de sangre y se ve a simple vista (> 100hematies/campo). Puede presentarse monosintomática, es decir, sin otros síntomas como por ejemplo dolor focalizado en alguna zona anatómica, sintomatología miccional (escozor, polaquiuria...), fiebre, mal estado general (repercusión sistémica). Puede ser una hematuria fluida o con coágulos lo que puede provocar sintomatología de vaciado vesical por obstrucción vesico-uretral. Es un síntoma que se presenta en diversas y múltiples patologías, por lo que su atención en el Servicio de Urgencias dependerá de su intensidad y repercusión, siendo necesario o no el tratamiento de la causa desencadenante de dicho síntoma en este momento de la Urgencia hospitalaria.

La causa más frecuente de macrohematuria es la infección de vías urinarias bajas, si bien siempre hay que descartar la posibilidad de lesión tumoral a nivel urotelial, de origen vesical principalmente. Hasta un 20% de los pacientes que acuden a S.Urgencias por hematuria macroscópica presentan neoplasia vesical.
Es muy importante conocer de esa hematuria las características organolépticas y acompañamiento de coágulo, pues es muy determinante para establecer un diagnóstico de presunción. Una simple y sencilla visión directa de una orina recién emitida permitirá diferenciar la intensidad y características de ese tinte rojizo de la orina para poder sospechar una infección urinaria, un cólico renal o un tumor de vejiga. Importante realizar una exhaustiva y dirigida exploración física y anamnesis, ya que las características de la hematuria asociada a otros síntomas (síndrome miccional o dolor tipo cólico) indicarán entidades de perfil benigno, como infección del tracto urinario (ITU) o litiasis en su proceso clínico de cólico renoureteral (CRU).

2. DESARROLLO

Cuando un paciente consulta en S. Urgencias por hematuria, se le indicará orinar en un recipiente para valorar e identificar las características (el color y la intensidad) de la misma. Posteriormente, es clasificado en:

a. Hematuria macroscópica SIN coágulos
b. Hematuria CON coágulos

a.- Hematuria SIN coágulos

En el caso de que se trate de una **hematuria SIN coágulos**, no será subsidiaria de sondaje vesical y/o Lavado Vesical Continuo (LVC) en primera instancia. En estos casos se forzará la diuresis y se procederá a vigilancia estrecha hasta aclarado progresivo.

Una vez resuelto el cuadro y habiendo permanecido el paciente hemodinámicamente estable durante toda su estancia, podrá ser dado de alta por médicos desde el S. Urgencias.

b.- Si se trata de una hematuria CON coágulos que están dificultando la micción (en ocasiones el paciente debuta con RAO: Retención Aguda de Orina por este motivo) es preciso realizar sondaje vesical, extracción de coágulos y LVC hasta que la hematuria ceda. Se procederá a la colocación de sonda vesical de 3 vías (entre 20 y 24FG) y se instaurará tratamiento con sueros lavadores, preferiblemente fríos, tras haber realizado lavados manuales con la intención de extraer los coágulos acumulados y retenidos en vejiga.

Por acuerdo entre el Servicio de Urología y el de Urgencias HUFJD, el paciente podrá permanecer en observación hasta resolución del cuadro, pudiendo ser dado de alta por el Servicio de Urgencias con cita / revisión en consultas del Servicio de Urología.

En caso de no resolverse el cuadro a lo largo de las horas siguientes de haber iniciado las medidas de resolución en la Urgencia del hospital (varias horas acordado en 8 horas como modelo de estrategia organizativa), se solicitará valoración por el Urólogo de guardia, quien decidirá la actitud a seguir con el paciente. Se ha establecido como estrategia organizativa que en caso de haber permanecido 23 horas en S. Urgencias, se procederá a continuar la atención al paciente en cuanto a futuros estudios y tratamientos en la planta de hospitalización de Urología

Durante su estancia en S. Urgencias:

- Se debe realizar una analítica de sangre completa (hemograma, bioquímica y coagulación) y completar estudio diagnóstico etiopatogénico según precise y diagnóstico de presunción. Está indicado repetir dichas pruebas en caso de no resolución del cuadro en el tiempo estimado y en función de las características y estabilidad hemodinámica del paciente (anemización, condición de anticoagulación, hipotensión…).

- El ritmo del suero lavador será ajustado continuamente en función de la intensidad de la hematuria, no debiéndose suspender, ni cambiar el ritmo, bajo ninguna circunstancia

sin supervisión de enfermería entrenada en el paciente urológico o previa orden médica.

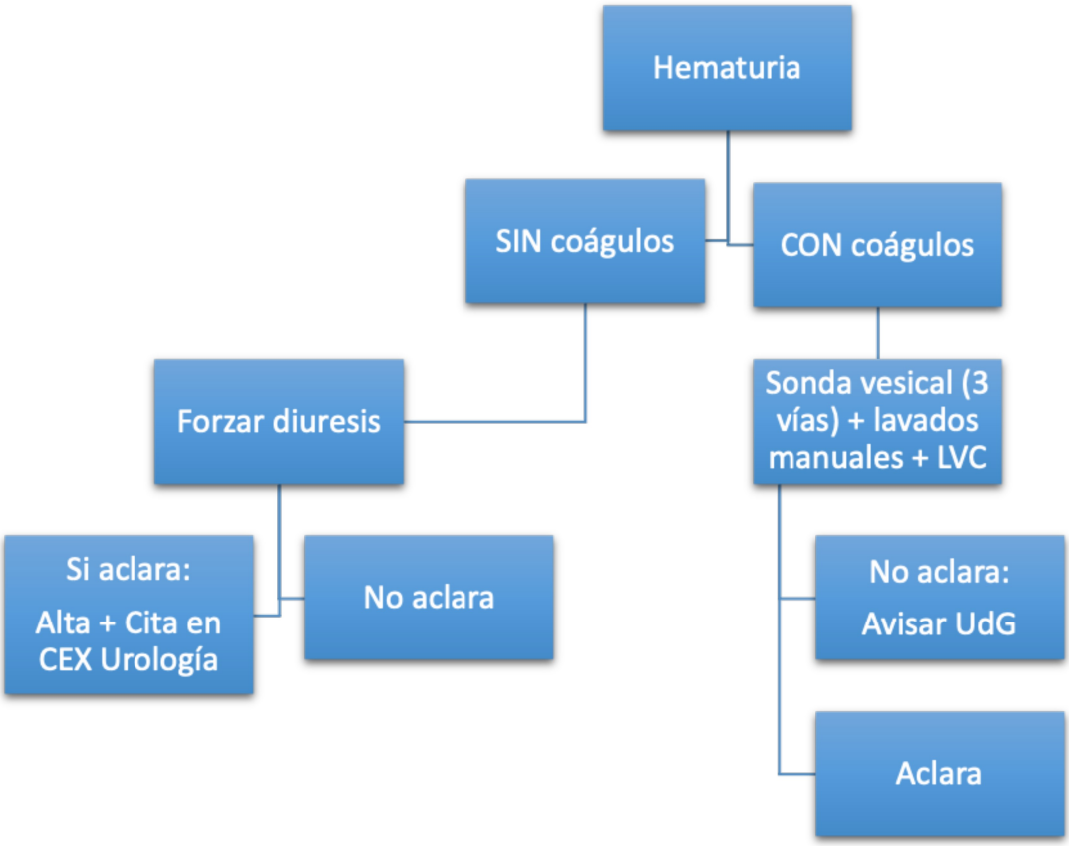
- Es importante a la vez mantener la permeabilidad del sistema estando pendiente de la obstrucción por coágulos residuales o de nueva formación. Para ello se precisa una vigilancia constante la permeabilidad del sistema lavador, realizando lavados manuales si fuera preciso por hematuria franca o presencia de coágulos.

Al alta del S.Urgencias se procederá según indicación:

- Citar al paciente en consulta externas de Urología en el plazo de 15 días previa realización de las siguientes estudios de diagnóstico complementarios:

  - Ecografía Abdominal y de Aparato Urinario.
  - Citología de orina.
  - Analítica sanguínea de control (en caso de anemización).
  - Urocultivo y/o resultados de urocultivo previo (si extraído en S. Urgencias).

3. ANEXOS



LVC: Lavado Vesical Continuo
CEX: Cita en consultas externas
UdG: Urólogo De guardia

4. BIBLIOGRAFIA

- EAU Guidelines on Urological Infections; G. Bonkat (Chair), R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S.E. Geerlings, B. Köves, S. Schubert, F. Wagenlehner. Guidelines Associates: W. Devlies, J. Horváth, G. Mantica, T. Mezei, A. Pilatz, B. Pradere, R. Veeratterapillay
- Gerber G, Brendler C. Evaluation of the urologic patient. En: .Campbell-Walsh Urology. Tenth edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012. pp. 73-98.
- Hicks D, et al. Management of macroscopi haematuria in the emergency department. Emerg Med J 2007;24:385-390.